

Infeksi Tenggorok

Topik Bahasan

Tonsilitis akut/ kronik

Adenoiditis akut/kronik

Faringitis akut/ kronik

Laringitis akut/ kronik

Tonsilitis Akut



- Definisi: infeksi akut jaringan tonsil
- Etiologi: virus, bakteri
- Insiden: anak, dewasa
- Patologi: radang → hiperemi, edema → eksudat, detritus
- Gejala klinis: Tenggorok rasa kering, nyeri telan, intake kurang, referred pain, panas tinggi, nyeri kepala, mual, muntah

PEMERIKSAAN

- “*Plummy voice*”
- “*Foetor ex ore*”
- Ptialismus
- Tonsil edem, hiperemi, detritus
- Ismus fausium menyempit
- Palatum mole, arkus ant./post. → edem, hiperemi
- Kelenjar limfe membesar – nyeri tekan

Diagnosa banding :

DIFTERITONSIL → *pseudomembrane sampai keluar tonsil , Bull neck*

Penyulit :

1. Lokal

- Peritonsilitis (infiltrat peritonsil)
- Abses peritonsil
- Abses parafaring

2. Sistemik (Strep. beta-hemolitikus)

- Glomerulonefritis akut
- Penyakit jantung reumatik
- Endokarditis bakterial sub akut

Terapi

- Terapi simptomatik: istirahat, antipiretik, hidrasi, analgetik dll
- Antibiotik: penicillin, makrolide

Komplikasi

- Abses peritonsil → pungsi → insisi drainase
- Abses parafaring → pungsi → insisi drainase
- Sistemik → tonsilektomi

Tonsilitis Kronik

Definisi

Infeksi akut berulang jaringan tonsil → hipertrofi folikel → tonsil hipertrofi

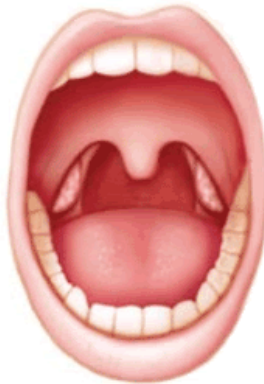


Tonsil hipertrofi



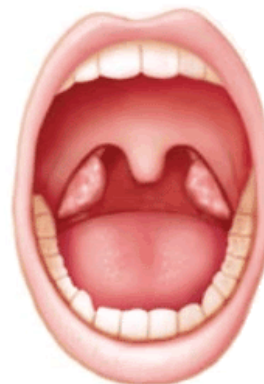
0

Surgically removed tonsils



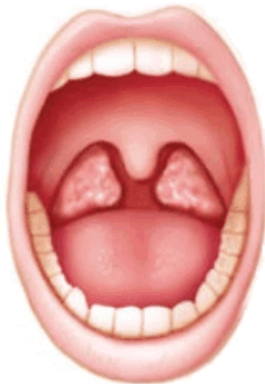
1

Tonsils hidden within
tonsil pillars



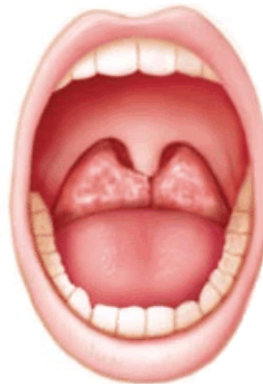
2

Tonsils extending to the
pillars



3

Tonsils are beyond the
pillars



4

Tonsils extend to midline

Keluhan penderita :

- nyeri telan ringan → hebat (eksaserbasi akut)
- rasa mengganjal
- “ *foetor ex ore* ”
- buntu hidung (ngorok) → adenoid membesar
- “ *adenoid face* ”
- gangguan pendengaran (adenoid membesar)

Pemeriksaan :

- tonsil membesar, hiperemi
- kriptas melebar → detritus (+) atau bila ditekan
- arkus ant. & post. hiperemi
- “*adenoid face*”
- fenomena palatum mole (-)

Penatalaksanaan :

- Serangan akut → sama dengan tonsilitis akut
- Tonsilektomi / adenotonsilektomi →
bila serangan >6 kali dalam satu tahun

Adenoiditis Akut

Definisi :

Radang akut dari adenoid pada bayi – anak <12 tahun

Gejala klinis :

1. Keluhan (dari ibunya) :

- panas tinggi → konvulsi
- hidung mampet → sulit nafas → intake menurun, pilek

2. Pemeriksaan (dikerjakan pd anak besar & kooperatif

Terapi :

- simtomatis (antipiretik, analgetik)
- antibiotika (ampicillin, amoxicillin, amoxiclav, macrolide)

Komplikasi :

- melalui tuba eustachius → kavum timpani → OMA, OME
- ke bawah → laring, trakeitis, bronkitis, bronkopneumoni
- Sinusitis akut

Adenoiditis Kronik

Definisi: infeksi akut berulang pada jaringan adenoid → adenoid hipertrofi

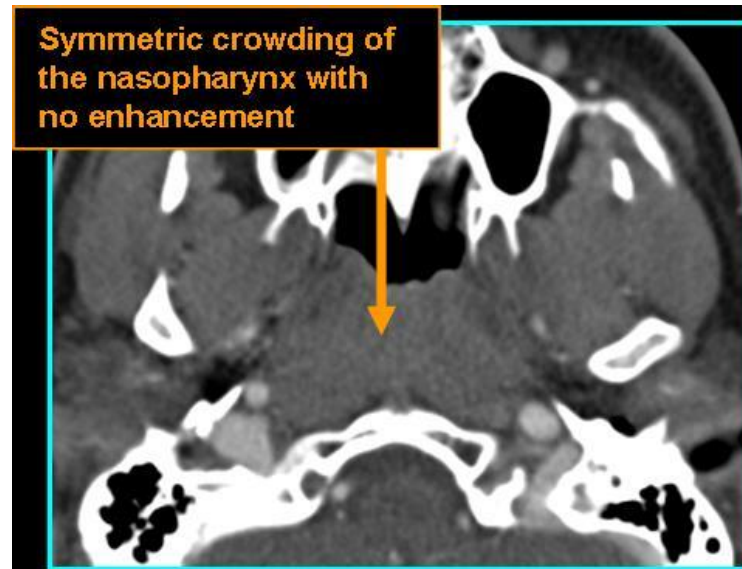
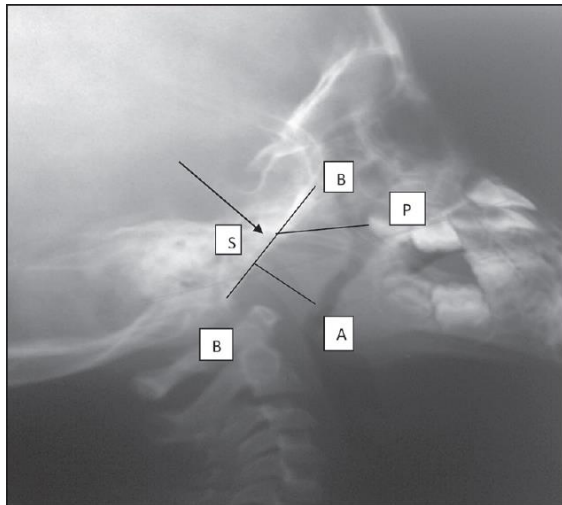
Gejala klinis: rinolalia, adenoid face, sefalgia, batuk kronik, intake menurun, oklusi tuba eustasius → pendengaran menurun

Pemeriksaan:

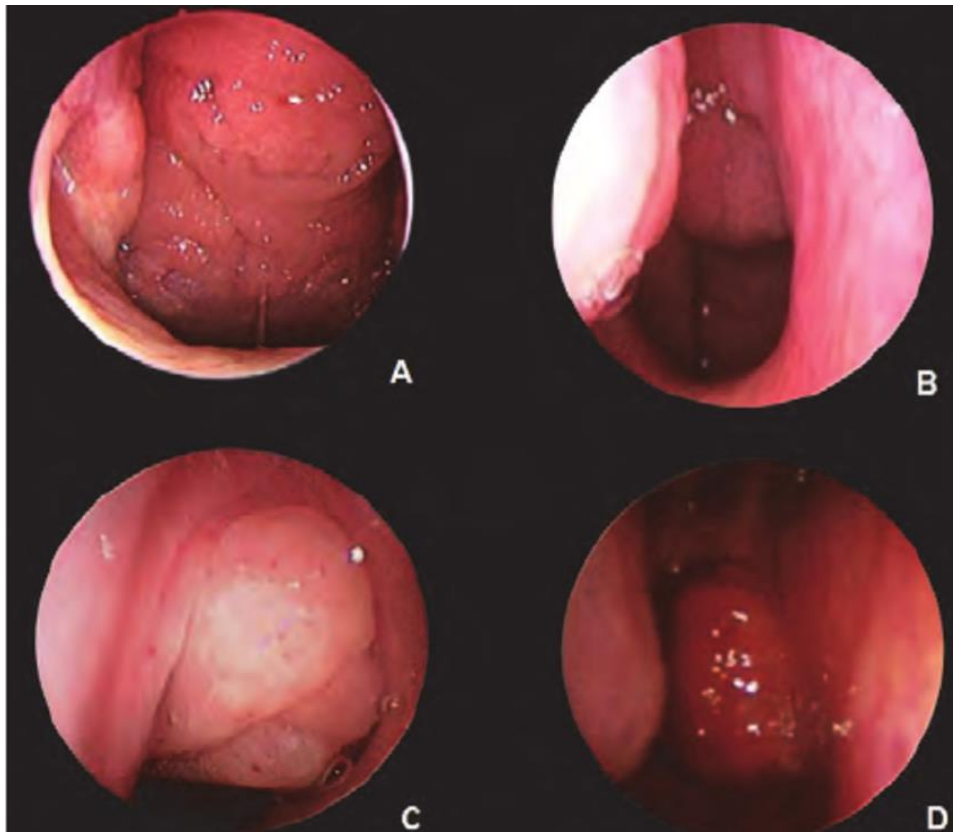
- *RA* : Adenoid membesar
Phenomena palatum mole (-)
- *RP* : Adenoid membesar dan tidak hiperemi

Pemeriksaan tambahan:

- Endoskopi, foto skull lateral, CT Scan



Adenoid hipertrofi



- Derajat 1:
menggantung di koana
- Derajat 2: menutup
koana 50 %
- Derajat 3: menutup
2/3 koana

FARINGITIS AKUT

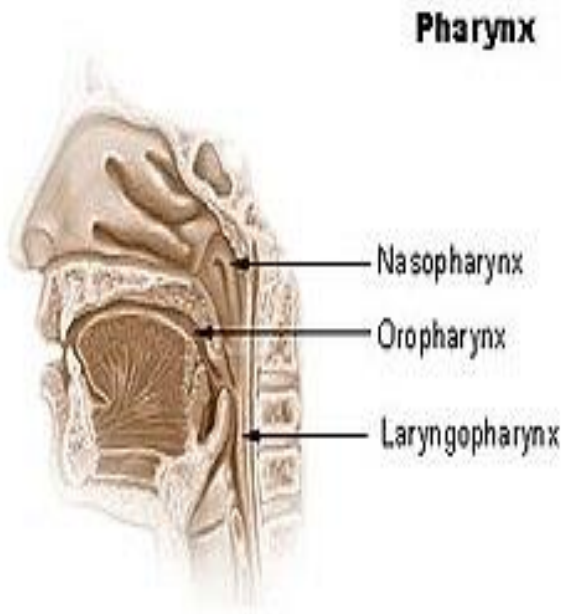
Infeksi akut pada mukosa faring dan jar.
limfoid faring

Etiologi :

- Virus : rhino v., corona v., v. influenza A & B, parainfluenza, adeno v., dll
- Bakteri : streptokokus beta hemolitikus grup A, B, C dan G, stafilokokus, hemofilus, neisseria sp, korine bakterium sp, dll.

Sering bersamaan dengan infeksi akut sal.
nafas atas :

rinitis akut, nasofaringitis,
tonsilitis akut





FARINGITIS AKUT



TONSILOFARINGITIS AKUT

Penyebaran : Droplet infection

Gambaran klinis

- dapat didahului rinitis akut, konjungtivitis, malaise, badan, dan nyeri kepala. panas
- nyeri tenggorok yg memberat saat menelan yg menjalar ke telinga dapat
- mukosa faring : hiperemi, edem, t.u. jar. limfoid : tampak garis2 mukosa, kd2 tampak pustular follicles
- dapat terjadi limfadenopati klj. Leher
- bila menyebar ke laring : suara parau, batuk2

Terapi

- Self limiting disease
- Simptomatis
- Antibiotik

Komplikasi

- Lokal: sinusitis, OM, laringitis, trakeobronkitis, pneumonia
- General: meningitis, ensefalitis, miokarditis

FARINGITIS KRONIK

	Nonspesifik	Spesifik
Etiologi	Sumber infeksi dari penyakit lain, asap rokok, karies gigi dll	Sifilis, tuberkulosis, toxoplasmosis, lepra, skleroma, jamur
Gambaran Klinis	rasa tidak nyaman ditenggorok, nyeri telan, kadang sakit telinga. Gb.an pulau2 jar. limfe pd dind. belakang faring mengalami pembesaran dan kemerahan	Tergantung penyebab Sifilis → papul yang pecah menjadi ulkus, tidak nyeri Tb → lesi multipel yang sangat nyeri
Diagnosis	Anamnesis dan pemeriksaan fisik	Serologi, mikrobiologi
Tatalaksana	Bila diket penyebab → diobati atau dihindari, obat kumur	Tergantung penyebab



TONSILOFARINGITIS DIFTERI

Infeksi akut mukosa faring yg spesifik ok kuman difteri. Biasanya juga mengenai tonsil → = difteri faring dan tonsil (TONSILOFARINGITIS DIFTERI).

Juga dpt terjadi pd hidung, laring

Etiologi : *Corynebacterium diphtheriae* (gram positif)

Di negara maju dimana program imunisasi sudah sangat baik : jarang didapatkan

Dapat menyebar cepat di tempat :

- penduduk terlalu padat
- pelayanan kesehatan <

Gambaran klinik :

- Malaise, panas badan subfebril, sakit kepala, nyeri telan tidak hebat
- Lokal : membrana/beslag keabu2an pada : tonsil, faring dan uvula
- Serviko limfadenopati : regio jugulo digastrik (= *bull neck*)
- Membrana dapat menyebar ke laring → obstruksi laring

Tanda beslag / membran difteria :

- Beslag kotor warna keabu abuan
- Melekat erat dengan jaringan dibawahnya → berdarah bila dilepas
- Meluas keluar tonsil

Karena kuman mengeluarkan toxin → nekrosis di jaringan mukosa

Asimptomatik → kematian dalam waktu yang singkat

Lokasi primer dapat di faring (tonsil), laring, hidung

Komplikasi

Jangka Pendek : Bila ke laring → obstruksi jalan nafas → trakeotomi

Jangka Panjang : Bisa menyebabkan parese otot perifer pada palatum mole dan otot pernafasan

Myokarditis → gangguan kontraksi jantung
aritmia



Diagnosis Banding :

Tonsilitis oleh karena streptokokus

Komplikasi :

- Sistemik ok penyebaran eksotoksin
- Dapat terjadi kematian :
 - * Toxaemia →
 - miokarditis
 - defek konduksi pd jantung
 - aritmia → kegagalan sirkulasi akut
 - trombositopenia
- Neurologi :
 - 3-6 minggu ssd onset difteri
 - paralisa : pal molle, diafragma, otot2 mata, kadang2 sindr. Guillain-Barre

Terapi :

Px diisolasi scr ketat sp kead akut dilampai & biakan (-)

- Tx didasarkan gambaran klinik

- Difteri ringan (mata, hidung, kulit) : ADS 20.000 IU im

- Difteri sedang (tonsil, faring, laring) :

ADS 40.000 – 60.000 IU iv

- Difteri berat (dg penyulit) : ADS 100.000 IU iv dg tetesan

- Penisilin prokain 600.000 – 1.2 juta IU/24 jam, im 1-2 x/hari,
selama 10 hari → Bila alergi thd Penisilin,
dpt digunakan Eritromisin 50 mg/kgbb/24 jam (maks 1 gram)p.o

3-4 x/hari, selama 10 hari.

- Bila carrier : TONSILEKTOMI (4-6 mngg stlh sembuh)

- Imunisasi

PERITONSILITIS AKUT (PERITONSILER INFILTRAT)

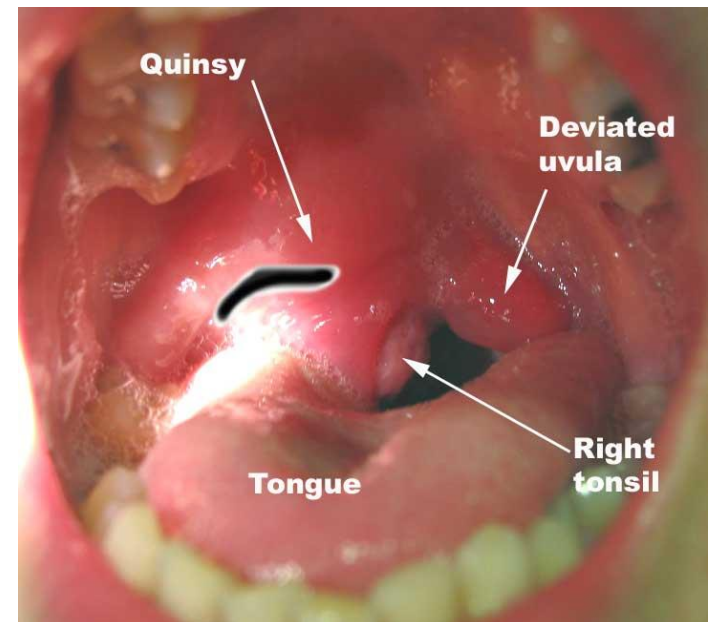
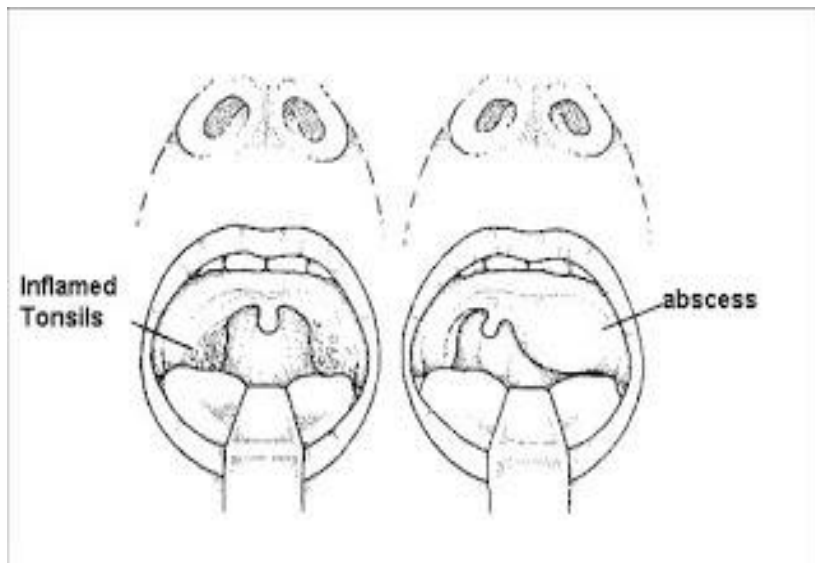
→ merupakan lanjutan dari Tonsilitis akut

Keluhan: nyeri telan sangat hebat → shg tdk bisa menelan ludah

Pemeriksaan: tonsil bengkak, merah, pembengkakan sampai palatum mole, tonsil terdorong ke tengah

Bila hasil punksi: pus negatif → infiltrat peritonsil → terapi antibiotika, analgesik

Bila pus positif → abses peritonsil → insisi, antibiotika



ABSES RETROFARING

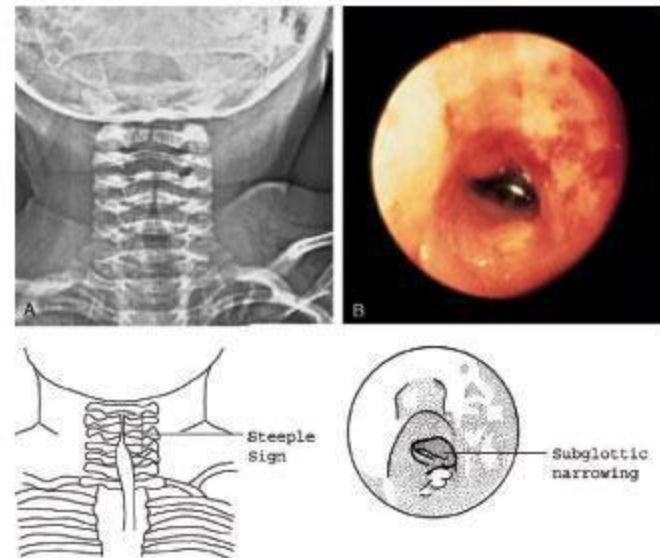
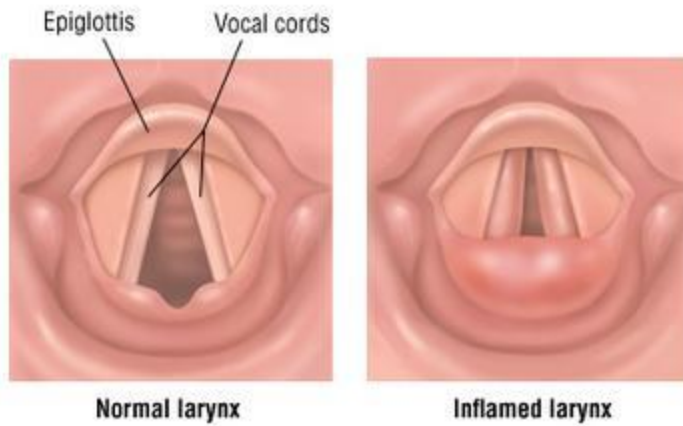
→ pd anak krn limfadenitis retrofaring yg menjadi abses, pd dewasa krn trauma

Gejala: demam, nyeri menelan, kadang2 sesak nafas (terutama pd anak2)

Pemeriksaan: pembengkakan pd dinding belakang faring, hiperemis

Tindakan: insisi dan aspirasi

LARINGITIS AKUT



LARINGITIS AKUT

Merupakan kelanjutan dari peradangan di daerah faring

Gejala: stridor, serak, demam, batuk

Pemeriksaan: Laringoskopi indirekta(LI)/ direkta (LD)

→ pita suara edem, hiperemis, gerakan menurun kanan dan kiri

Pengobatan: antibiotika, anti inflamasi,
istirahat bicara

LARINGITIS DIFTERI

→ merupakan kelanjutan dr tonsilitis difteri

Gejala: sesak nafas, parau, demam



Penanganan:

1. ADS
2. bila ada sumbatan laring
➤ dilakukan trakeotomi
3. isolasi
4. istirahat baring
5. antibiotika (Penisilin)

LARINGITIS KRONIS

→ karena pengobatan laringitis akut tidak tuntas

Gejala: parau

Pemeriksaan: penebalan mukosa pita suara

Tatalaksana → vocal resting, vocal hygiene

